



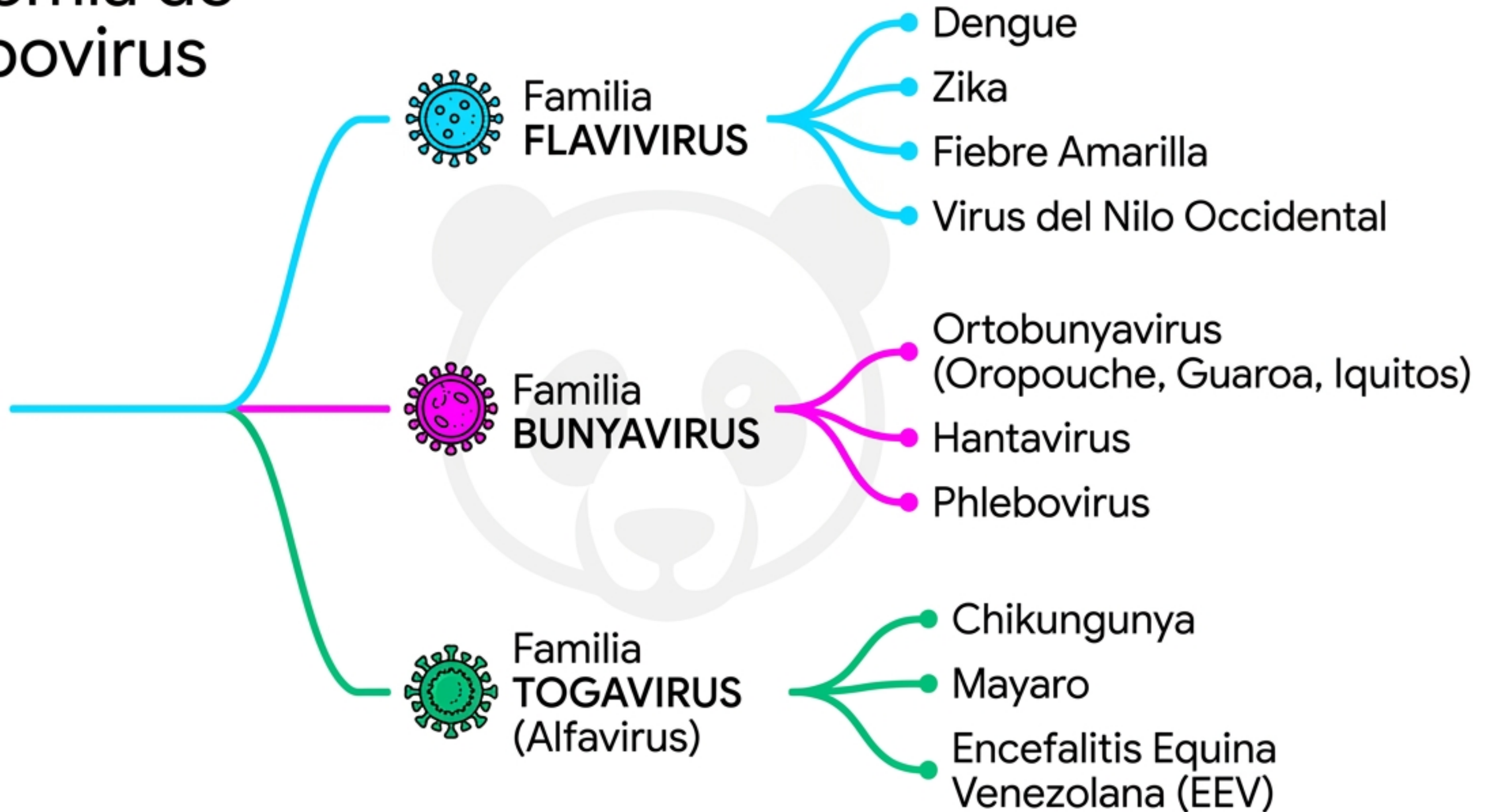
ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES



Manual Clínico Visual de Arbovirosis

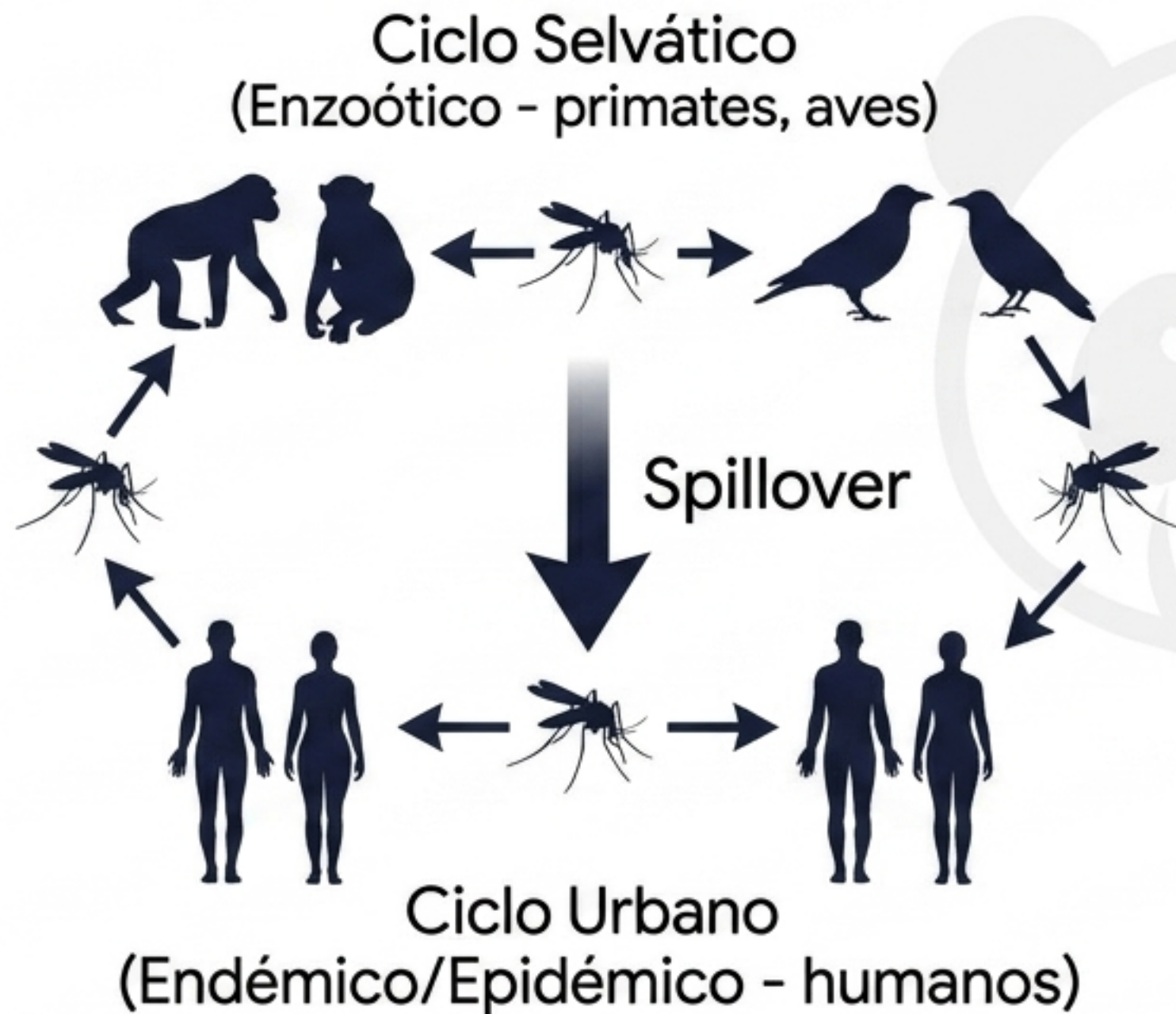


Taxonomía de los Arbovirus



Ciclos de Transmisión y Clasificación Sindrómica

Ciclos Epidemiológicos



Matriz Sindrómica

Hemorrágicas	→	Dengue, Fiebre Amarilla
Fiebre, artralgia, exantema	→	Dengue, Zika, Ortobunyavirus
Encefalitis	→	EEV, Encefalitis equina del oeste
Artritis/Artralgia persistente	→	Chikungunya, Mayaro

Perfil Clínico: Fiebre de Oropouche

Virología

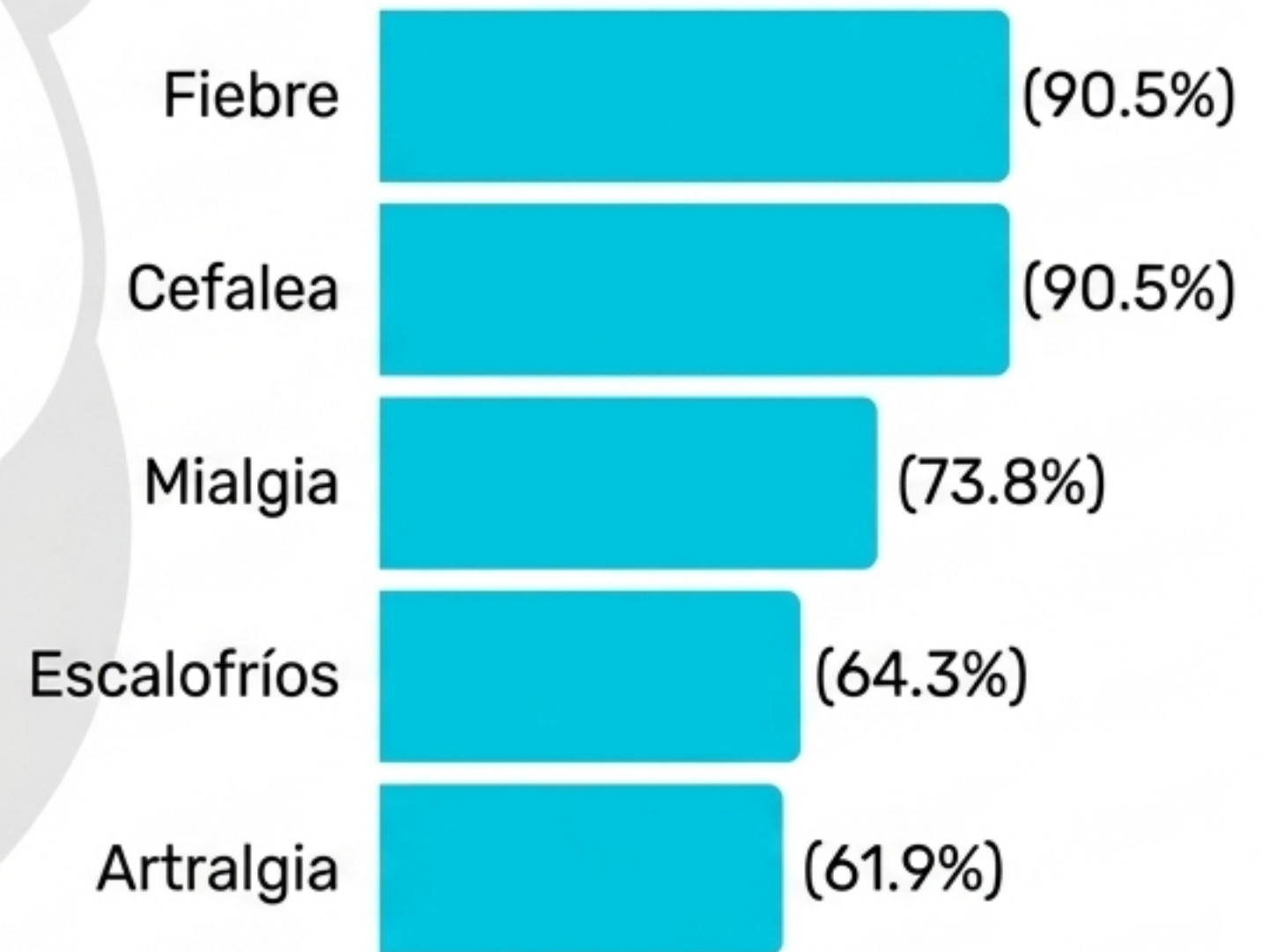
- Virus ARN de cadena simple.
- Genotipos I, II y III.
- El Tipo II está presente en Perú.

Vector



Transmitido principalmente por mosquitos del género *Culicoides* (jejenes).

Cuadro Clínico Agudo



Perfil Clínico: Encefalitis Equina Venezolana (EEV)



Vector principal:
Mosquitos del género *Culex*.

- **Virus** ARN de cadena simple (60nm).
- **Vector principal:** Mosquitos del género *Culex*.

Subtipos Epizoóticos
(Brotos epidémicos mayores)

Subtipos IAB y IC

Subtipos Enzoóticos
(Circulación silvestre endémica)

Subtipos ID, IE y del II al VI

Dengue: Virología y Fisiopatología del Daño Endotelial

Virología

- ARN monocatenario (+).
- 4 Serotipos (DEN-1 a DEN-4).
- Proteínas Estructurales (prM, E, C) y No Estructurales (NS1 a NS5).

Aumento Severo de Permeabilidad Vascular



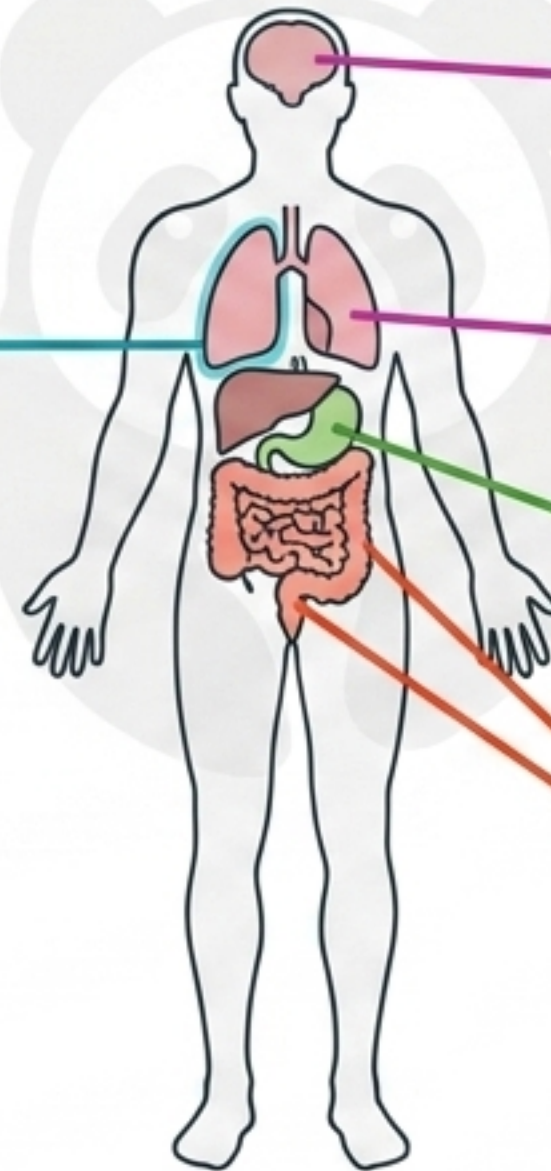
Pleura: Derrame pleural

Cerebro: Encefalopatía
(Lesión Barrera Hematoencefálica)

Alvéolo: Hemoptisis

Abdomen: Ascitis

Intestino/Tracto urinario:
Melena, Hematuria



Dengue: Clasificación de Gravedad (Triage)

Dengue sin signos de alarma (DSSA)	Dengue con signos de alarma (DCSA) - ¡Basta 1 solo signo para fase crítica!	Dengue Grave
Fiebre 2-7 días + Nauseas, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgia, petequias, leucopenia.	Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, lipotimia, hepatomegalia >2cm, aumento progresivo del hematocrito.	Choque o dificultad respiratoria por extravasación, Sangrado grave, Daño orgánico severo (TGO/TGP ≥ 1000 , Glasgow < 13).
Manejo ambulatorio (Primer nivel)	Internamiento en hospital (Monitorización)	Hospitalizar en UCI Inmediato

Dengue: Flujograma de Manejo Clínico (Grupo B2)

Objetivo: Prevenir el shock. Reposición DINÁMICA.

Iniciar: Solución cristaloide isotónica (Hartman/SSN 0.9%) a 10 ml/kg por **1 hora**.

Si hay mejoría clínica

Reducir gradualmente el goteo con monitoreo horario:
5-7 ml/kg/h -> luego ->
3-5 ml/kg/h -> luego 2-4 ml/kg/h.

Si **NO** hay mejoría

Repetir carga de 10 ml/kg en 1 hora.
Si persiste inestable tras 3 cargas, reclasificar como Dengue Grave (UCI).

Criterios de Mejoría Clínica

- ✓ Signos vitales estables.
- ✓ Desaparición de signos de alarma.
- ✓ Diuresis normal/aumentada.
- ✓ Disminución del hematocrito.

Dengue: Reglas de Oro en UCI y Monitoreo Hemodinámico

Fórmula Clave:

$$\text{PAM} = \left[(\text{PS} - \text{PD}) / 3 \right] + \text{PD}$$

(Normal adulto: 70-95 mmHg)



Precauciones (Riesgo de Sangrado Grave):

- Usar sonda orogástrica (nunca nasogástrica).
- Evitar catéter subclavio (preferir vía periférica o femoral).
- Evitar procedimientos de drenaje invasivos en tórax y abdomen.



Peligro de Sobrecarga Hídrica:

- Prohibido el uso de soluciones hipotónicas.
- Peligroso continuar infusión de líquidos EV en fase de recuperación.
- Peligrosa la administración rápida sin reevaluación hemodinámica constante.

Chikungunya: Epidemiología y Fase Aguda

Familia Togavirus (Alfavirus).

Incubación: 4 a 8 días.

Fase Aguda (1-10 días):

- **Fiebre alta** (76-100%).
- **Poliartralgia/Poliartritis** migratoria incapacitante (71-100%).
- **Rash** maculopapular (28-77%).



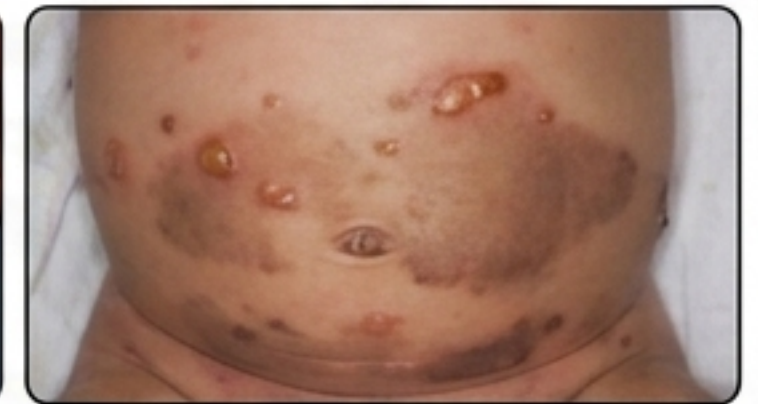
Rash en Tronco



Rash en Palmas



Lesiones Bullosas Infantiles



Manifestaciones Cutáneas Adicionales

Chikungunya: Fase Crónica y Manifestaciones Atípicas

Cuadros Atípicos de Gravedad

Neurológico:
Guillain-Barré,
Meningoencefalitis.

Cuadros Atípicos de Gravedad

Cardiovascular:
Miocarditis,
Inestabilidad
hemodinámica.

Cronificación: Artralgia persistente por meses o años. **Postura encorvada** severamente incapacitante.



Cuadros Atípicos de Gravedad

Ocular: Uveítis,
Neuritis óptica.

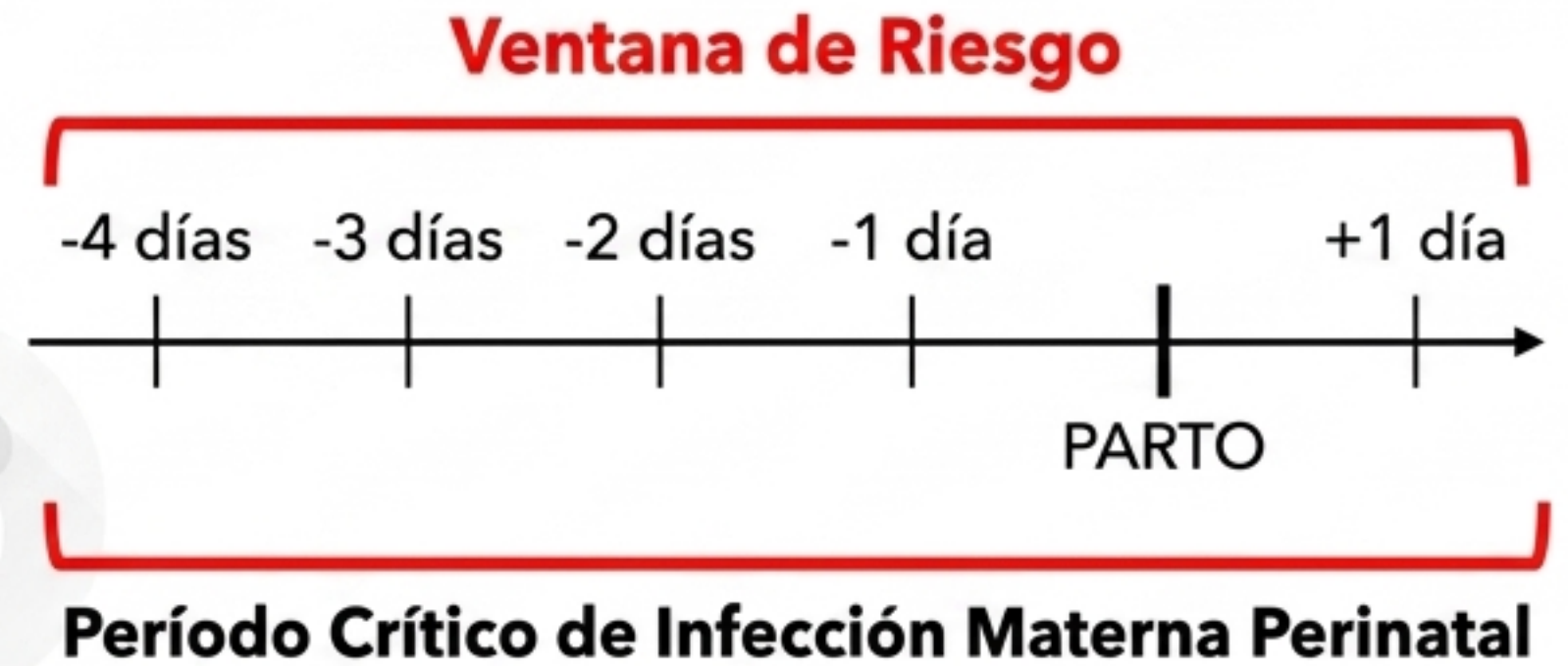
Cuadros Atípicos de Gravedad

Renal:
Insuficiencia renal
aguda.

Chikungunya: Riesgo Gestacional y Transmisión Vertical



Embarazo: Riesgo asociado de abortos espontáneos esporádicos. La cesárea NO previene la transmisión vertical



Clínica Neonatal Severa

Fiebre persistente, inapetencia, edema distal, crisis convulsivas, meningoencefalitis, anomalías ecocardiográficas.

Zika: Diagnóstico Diferencial y Teratogenia

Clínica Aguda del Adulto

Fiebre
Sarpullido
Dolor articular

Signo Diferencial Clave:
CONJUNTIVITIS NO PURULENTA
(Ojos enrojecidos)

Síndrome Congénito por Zika



5 Defectos Clave

1. **Microcefalia grave** (cráneo parcialmente colapsado).
2. **Reducción severa del tejido cerebral.**
3. **Cicatrices maculares** y daño ocular posterior.
4. **Pie equinovaro** y movimiento **articular** limitado.
5. **Hipertonía muscular** restrictiva posnatal.

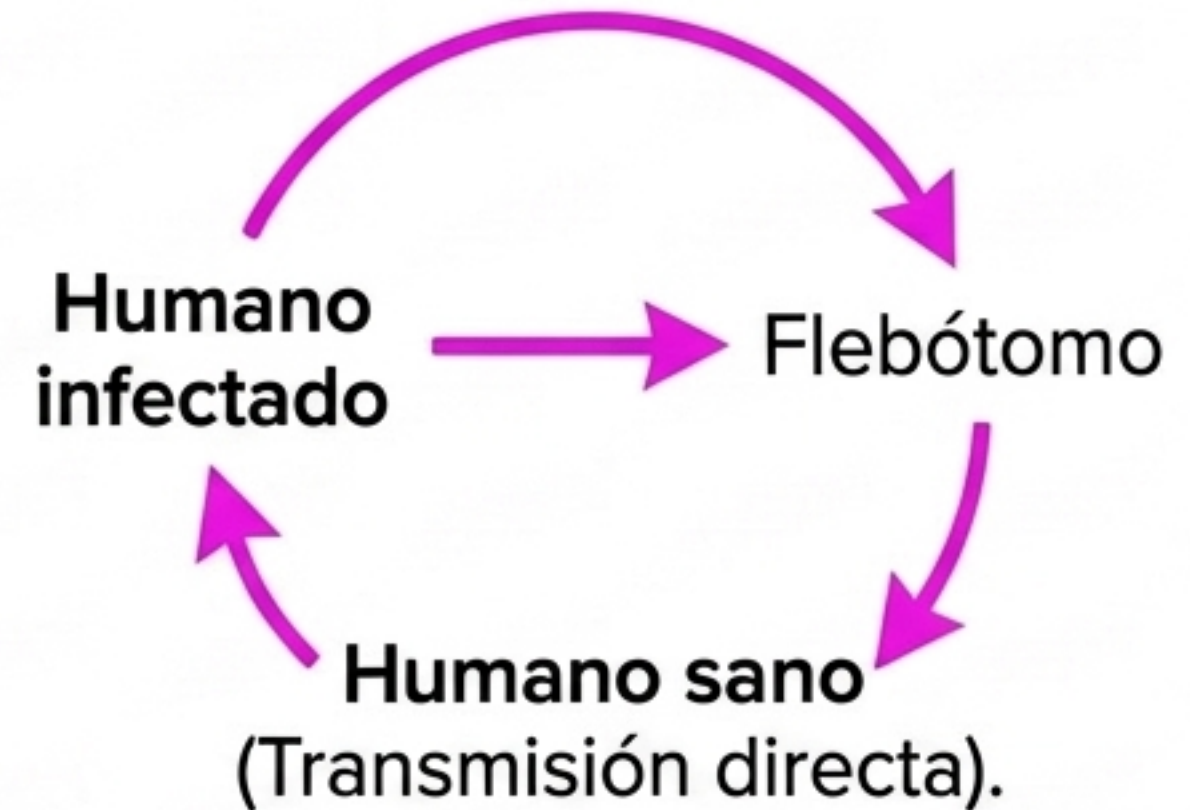
Enfermedades Parasitarias Reemergentes: **Leishmaniasis**

Vector Universal: Mosca de la arena (Flebótomo).

Zoonosis (Américas)



Antroponosis (Viejo Mundo)



Signo Patognomónico: Úlcera cutánea de fondo limpio, tejido granuloso, bordes regulares elevados, base dura e INDOLORA.

Matriz Diferencial Definitiva de Arbovirosis

Enfermedad	Vector Primario	Signo Clínico Diferencial (Cardinal)	Riesgos de Gravedad (Teratogénico/Hemorrágico)
DENGUE	Aedes 	Dolor retroocular, riesgo de shock por fuga de plasma	Riesgo Hemorrágico/Choque: ALTO (Rojo - ). Teratogénico: Bajo.
CHIKUNGUNYA	Aedes 	Poliartritis migratoria incapacitante severa	Riesgo Crónico Articular: ALTO (meses/años). Teratogénico: Transmisión perinatal aguda.
ZIKA	Aedes 	Conjuntivitis no purulenta (ojos rojos)	Riesgo Teratogénico: ALTO (Rojo -  Microcefalia y Síndrome Congénito).
OROPOUCHE	Culicoides 	Similitud al Dengue con alta tasa de cefalea, sin extravasación de plasma típica	Riesgo Hemorrágico: Bajo. Riesgo Teratogénico: Bajo.